Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Rhinoplastie

Chirurgie esthétique du nez (associée, si nécessaire, à une correction des voies respiratoires nasales)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Technique prévue : ☐ Technique ouverte ☐ Technique fermée ☐ À décider par le chirurgien pendant l'opération

Actes réalisés au cours de la même intervention : ☐ Septoplastie ☐ Réduction des cornets ☐ Aucun _____

Origine du greffon cartilagineux : ☐ Intérieur du nez (cloison) ☐ Oreille ☐ Côte ☐ Non nécessaire a priori _____

Plaintes et attentes du patient : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

La rhinoplastie est une opération qui vise à remodeler l'apparence extérieure du nez (le dos du nez, une bosse, la pointe, la largeur du nez, les narines et son harmonie avec le visage). Si vous présentez une déviation de la paroi centrale du nez gênant la respiration (déviation de la cloison nasale), un affaissement des parois latérales du nez (ailes du nez) ou des cornets hypertrophiés, ceux-ci peuvent être corrigés au cours de la même opération.

La forme du nez résulte de caractéristiques héréditaires, de modifications survenues pendant la croissance ou de traumatismes antérieurs (coup, fracture). Ces structures ne se modifient pas d'elles-mêmes. Le but de l'opération est d'atteindre les **objectifs réalistes** que nous définissons ensemble et d'obtenir un nez **naturel, en harmonie avec votre visage et permettant de respirer confortablement**.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'opération est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire. Avant l'intervention, votre nez est examiné et photographié, et un plan est établi avec vous.

1. **Incision :** Avec la technique fermée, toutes les incisions se trouvent à l'intérieur du nez et aucune cicatrice n'est visible de l'extérieur. Avec la technique ouverte, une petite incision d'environ 4–5 mm est également pratiquée sur le fin pont de peau situé entre les narines (la columelle) ; cette cicatrice devient généralement à peine perceptible avec le temps.
2. **Remodelage de la charpente du nez :** La peau et les tissus mous sont délicatement décollés. S'il existe une bosse, elle est réduite aux dépens de l'os et du cartilage, ou corrigée par des techniques de préservation du dos du nez. Les cartilages de la pointe sont remodelés à l'aide de points de suture.
3. **Rétrécissement/redressement des os (ostéotomie) :** S'il faut rétrécir ou redresser des os du nez larges ou déviés, des coupes osseuses contrôlées sont réalisées. Cette étape peut augmenter le risque d'ecchymoses et de gonflement.
4. **Soutien et greffons :** Pour aider le nez à garder sa forme à long terme et maintenir les voies respiratoires ouvertes, des soutiens cartilagineux (greffons) sont utilisés si nécessaire. Le cartilage est prélevé en priorité à l'intérieur du nez (sur la cloison) ; s'il ne suffit pas, du cartilage d'oreille ou de côte peut être utilisé. Ce point sera discuté avec vous avant l'opération.
5. **Correction fonctionnelle :** Si nécessaire, la paroi centrale du nez (cloison nasale) est redressée et les cornets sont réduits.
6. **Fermeture et attelle :** Les incisions sont refermées par de fins points de suture. Une attelle de protection est placée sur le dos du nez ; si nécessaire, des attelles souples en silicone ou des mèches permettant de respirer sont placées à l'intérieur du nez.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale	Environ 2–4 heures	Généralement une nuit d'hospitalisation

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Une forme du nez plus naturelle, plus équilibrée et en harmonie avec votre visage
- La disparition de l'obstruction nasale, si elle existe, et une respiration plus facile
- Une contribution à un meilleur bien-être personnel

La plupart des patients sont satisfaits du résultat. Cependant, le nez se trouve au centre du visage et sa cicatrisation est longue ; le résultat définitif apparaît en **12–18 mois**. Les publications indiquent qu'environ **5–15 %** des patients peuvent avoir besoin d'une opération de correction, mineure ou plus importante (rhinoplastie secondaire ou « révision »). Le résultat est plus difficile à prévoir pour les nez à peau épaisse, déjà opérés ou ayant subi un traumatisme important.

4 Autres options thérapeutiques

- **Ne pas se faire opérer :** S'agissant d'une intervention esthétique, vous avez toujours la possibilité de ne pas la faire.
- **Remodelage du nez par injections de produit de comblement (« rhinoplastie médicale ») :** Peut camoufler temporairement une petite bosse ou un petit creux ; elle ne réduit pas la taille du nez, n'améliore pas la respiration et comporte ses propres risques, comme l'obstruction d'un vaisseau sanguin.
- **Chirurgie fonctionnelle seule (septoplastie/réduction des cornets) :** Si le seul problème est respiratoire, elle peut être réalisée sans modifier la forme extérieure du nez.
- **Traitement médicamenteux :** Les sprays nasaux peuvent soulager une obstruction due à une allergie ou à un gonflement de la muqueuse ; ils ne corrigent pas les déformations structurelles.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'opération n'est pas réalisée, la forme actuelle de votre nez restera inchangée. Si vous avez des troubles respiratoires d'origine structurelle (déviation, affaissement des ailes du nez), ils ne s'amélioreront pas d'eux-mêmes, mais ils ne représentent généralement pas un danger urgent pour votre santé.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Si vous avez pris de l'**isotrétinoïne** (médicament contre l'acné, par ex. Roaccutane) au cours des 6–12 derniers mois, signalez-le-nous impérativement ; elle peut affecter la cicatrisation de la peau et la date de l'opération pourra être planifiée en conséquence.
- Des analyses de sang et, si nécessaire, d'autres examens sont réalisés avant l'opération, et vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- Vous ne devez rien manger ni boire pendant les **6–8 heures** précédant l'opération (veuillez suivre les consignes du médecin anesthésiste).
- Le jour de l'opération, ne portez ni maquillage, ni vernis à ongles, ni bijoux, ni lentilles de contact. Il est conseillé qu'un proche vous accompagne pendant la première journée après l'opération.
- L'opération peut être reportée en cas d'acné active ou d'infection cutanée du visage, de grippe ou d'infection des voies respiratoires supérieures.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

48 premières heures	Une obstruction nasale, un léger suintement, des maux de tête et un gonflement du visage sont normaux. La douleur est généralement légère à modérée et soulagée par des antalgiques. Dormir la tête surélevée et appliquer du froid aident à réduire le gonflement. **Si** des ecchymoses (bleus) apparaissent, elles se situent autour des yeux et disparaissent en 7–10 jours.
1re semaine	Les éventuelles attelles en silicone/mèches placées à l'intérieur du nez sont généralement retirées entre le 2e et le 5e jour, et l'attelle externe et les fils vers le **7e jour**. Il vous sera demandé de rincer l'intérieur du nez au sérum physiologique. La plupart des patients reprennent un travail de bureau et une vie sociale en 7–10 jours.
2e–6e semaine	La plus grande partie du gonflement disparaît, mais la pointe du nez peut rester ferme et légèrement engourdie. Les efforts physiques intenses, les sports de contact et la natation doivent être reportés d'environ **4–6 semaines**. Les lunettes ne doivent pas être portées pendant au moins **6 semaines**, sauf si elles sont maintenues par un sparadrap de façon à ne pas appuyer sur le dos du nez.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

3e–12e mois	Le gonflement résiduel, en particulier au niveau de la pointe, diminue progressivement. La forme du nez continue d'évoluer pendant cette période ; les petites irrégularités visibles au début disparaissent généralement.
12e–18e mois	Le résultat définitif apparaît. Si une retouche (révision) est jugée nécessaire, elle est généralement réalisée après un délai d'au moins 12 mois.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Obstruction nasale, léger suintement et écoulement teinté de sang (les premiers jours)
- Gonflement du visage et autour des yeux ; **si** des ecchymoses apparaissent, elles disparaissent en 1–2 semaines
- Engourdissement temporaire de la pointe du nez et des dents de devant ; pointe du nez ferme
- Diminution temporaire de l'odorat (s'améliore à mesure que le gonflement diminue)
- Évolution de la forme du nez au fil des mois

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Gonflement prolongé** — En particulier en cas de peau épaisse, le gonflement de la pointe peut durer un an ou plus. Il peut être atténué si nécessaire par des injections de corticoïdes.
- **Légère asymétrie et petites irrégularités** — Le visage lui-même n'étant pas parfaitement symétrique, de légères différences peuvent persister au niveau du nez ; de petites saillies osseuses ou cartilagineuses peuvent être perçues au toucher, mais ne sont généralement pas visibles.
- **Nécessité d'une révision (correction)** — Chez environ **5–15 patients sur 100**, une intervention de correction, allant d'une petite retouche à une opération plus importante, peut être nécessaire.
- **Croûtes et sécheresse à l'intérieur du nez** — Fréquentes les premières semaines ; disparaissent avec des lavages réguliers et une hydratation.

Situations peu fréquentes

- **Saignement de nez (épistaxis)** — Chez environ **1–3 patients sur 100**, un saignement nécessitant un méchage ou une intervention peut survenir. Très rarement, il peut être nécessaire d'arrêter le saignement au bloc opératoire.
- **Infection** — Survient chez **moins de 1 à 3 patients sur 100**. Elle guérit généralement sous antibiotiques ; rarement, il peut être nécessaire de drainer l'infection ou de retirer un greffon.
- **Respiration moins améliorée que prévu** — Votre obstruction nasale peut ne pas disparaître complètement ou, rarement, s'aggraver ; un traitement ou une opération complémentaire peut être nécessaire.
- **Trou dans la cloison (perforation septale)** — Un trou dans la paroi centrale du nez survient chez environ **1 patient sur 100**. Il ne provoque souvent aucun symptôme ; s'il entraîne un sifflement, des croûtes ou des saignements, un traitement peut être nécessaire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Collection de sang ou de pus dans la cloison (hématome / abcès de cloison)** — Lorsque la cloison est opérée, cette complication survient chez **moins de 1 patient sur 100**. Elle se manifeste par une obstruction croissante, des douleurs et de la fièvre dans les jours suivant l'opération. La collection doit être **drainée en urgence** pour éviter d'endommager le cartilage du nez ; en l'absence de traitement, une perte de cartilage et un affaissement du dos du nez (nez en selle) peuvent survenir, et une opération supplémentaire peut être nécessaire pour les corriger.
- **Adhérences à l'intérieur du nez (synéchies)** — Accolement des tissus à l'intérieur du nez ; s'ils provoquent une obstruction, ils peuvent être séparés par un geste simple.
- **Cicatrice visible** — Avec la technique ouverte, la cicatrice de la columelle peut rarement rester visible ; si les narines sont réduites, une fine cicatrice se forme dans le pli de l'aile du nez.
- **Engourdissement prolongé** — La diminution de la sensibilité de la pointe du nez ou des dents de devant peut durer plusieurs mois ; rarement, elle peut être définitive.
- **Problèmes liés aux greffons** — Avec le temps, les greffons cartilagineux peuvent se déplacer, se courber, se résorber partiellement ou devenir visibles sous la peau. Si du cartilage est prélevé sur l'oreille ou sur une côte, il existe un risque de douleur, de cicatrice et de saignement au niveau du site de prélèvement et, pour la côte, très rarement, de blessure de l'enveloppe du poumon (pneumothorax).

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Problèmes cutanés** — Amincissement de la peau, rougeur, petits vaisseaux visibles (télangiectasies) ou augmentation du tissu cicatriciel en cas de peau épaisse. Très rarement, en particulier chez les fumeurs et sur les nez déjà opérés, une mauvaise vascularisation de la peau peut entraîner une plaie et une perte de tissu. Des soins de plaie prolongés et une chirurgie réparatrice peuvent alors être nécessaires, et une cicatrice ou une déformation définitive peut persister.
- **Diminution ou perte définitive de l'odorat** — Très rare.
- **Problèmes des voies lacrymales et saignement autour de l'œil** — Très rarement, les coupes osseuses peuvent entraîner un larmoiement ou un saignement autour de l'œil.
- **Fuite de liquide cérébrospinal (LCS), méningite, perte de la vue** — Complications extrêmement rares, survenant dans **bien moins de 1 cas sur 10 000**, dues à une lésion des fines parois osseuses qui séparent le nez de la base du crâne et de l'œil. Si elles surviennent, un traitement hospitalier complémentaire (parfois en réanimation) et une opération peuvent être nécessaires ; une perte de la vue, si elle survient, peut être définitive.
- **Syndrome du choc toxique** — Maladie infectieuse très rare mais grave, liée à l'utilisation de mèches nasales (forte fièvre soudaine, éruption cutanée, chute de la tension artérielle), qui nécessite un traitement urgent. Elle impose une prise en charge hospitalière, parfois en réanimation, et peut mettre la vie en danger.
- **Insatisfaction psychologique** — Malgré un résultat techniquement réussi, une personne peut avoir du mal à s'habituer à sa nouvelle apparence. Discuter ouvertement des attentes avant l'opération réduit ce risque.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Saignement de nez qui ne s'arrête pas ou très abondant** malgré quelques minutes de compression et l'application de glace
- **Obstruction nasale croissante, douleur intense et gonflement du nez** dans les jours suivant l'opération (peut être le signe d'un hématome/abcès de la cloison)
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, douleur croissante, rougeur ou écoulement nasal malodorant
- **Forte fièvre soudaine, éruption cutanée, vertiges ou grande fatigue** alors que les mèches sont en place
- **Écoulement clair et aqueux** par le nez, en particulier s'il augmente lorsque vous vous penchez en avant ; ou maux de tête intenses et raideur de la nuque
- **Vision trouble ou double**, ou gonflement et douleur autour de l'œil augmentant rapidement
- Un coup sur le nez ou une modification soudaine de sa forme
- Essoufflement ou douleur thoracique

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Ne vous mouchez pas pendant les 2 premières semaines ; si vous devez éternuer, éternuez la bouche ouverte.
- Nettoyez l'intérieur de votre nez comme on vous l'a montré et aussi souvent que recommandé.
- Pendant au moins 6 semaines, évitez les chocs sur le nez, le port de lunettes reposant sur le dos du nez et le sommeil sur le ventre.
- Protégez la peau de votre nez du soleil pendant au moins 3 mois (crème solaire à indice élevé, chapeau).
- Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le voyage en avion est généralement sans danger après le retrait de l'attelle (vers le 7e jour).
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que la comparaison de mes photographies avant et après l'opération fait partie de l'évaluation du résultat, et que les simulations informatiques ou les photos d'exemple ne servent qu'à donner une idée et ne garantissent pas le résultat.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.